EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 70091
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 01-09-2023

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: DIEGO BERNABE SUAZO AVILA			**RUN**	: 8.014.666-3
F.Nac	: 04-05-1959	**Edad**	: 64 AÑOS, 3 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: Sargento Aldea 621			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	**Teléfono**	: 77451346		
Fecha Ingreso	: 2023-08-23	**Fecha Egreso**	: 01-09-2023	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.4-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN CEREBRO

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

- HIC talámico derecho ICH 1 (vaciamiento)
- Emergencia hipertensiva resuelta
- Antecedentes: HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61.4-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA EN CEREBRO (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Diestro mRS 0
Paciente previamente asintomático, el 22/08/23 a las 8:30 AM presenta despierta con evento de cefalea, asociado a vómitos, disartria y debilidad de hemicuerpo derecho por lo que consultan en HSC.
Al ingreso en HSC con Fc 87 lpm, ECG sinusal, PA 190/110 mmHg, Sat 97% amb y HGT 116 mg/dL. Por ausencia de disponibilidad de TC se traslada a HHM para estudio y evaluación por neurología, requiere uso de Labetalol previo a traslado. En HHM ingresa a cerca de las 14:00 horas con FC 86 lpm, PA 154/87, T° 36.5°C, Sat 97%. Al examen neurológico se describe en GCS 15 hemiparesia M4 derecha e hipoestesia BC derecha NIHSS 3. Se realizó TC de encéfalo sin contraste y angioTC en que se constata hematoma talámico izquierdo de 1.8x3.2x2.8 cms, volumen 8cc. En fase angiográfica sin alteraciones de relevancia. Se traslada a HSC para ingreso a UTI, se mantiene sin deterioro clínico, estacionario y se traslada a sala UPAC para continuar monitoreo, buena evolucion y se decide alta medica con HODOM para continuar evolución kinésica y fonoaudiológica
Ex neurológico:
- Mental: Vigil, parcialmente orientado en tiempo y espacio, inatento, sin alteración del lenguaje, disartria leve. GCS 14.
- PC: pupilas isocoricas, RFM +/+, CV conservado, OCM normal sin nistagmus, sensibilidad facial simétrica, PFC derecha leve. Protruye lengua en linea media, paladar blando simétrico.
- Motor: PMP prona y cae. Al testing hemiparesia BC derecha M4, ROT normales, plantar extensor derecho
- Sensitivo: hipoestesia crural derecha
- Cerebelo: HC izquierdo sin hallazgos
- Signos meningeos negativos.

PLAN DE MANEJO:

Cita en Poli de Neurología en 15 dias Dr. Norambuena

INDICACIONES AL ALTA

1. HODOM para continuar rehabilitacion kinesica y fonoaudiologica

2. HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
3. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
4. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL
5. AMLODIPINO COMPRIMIDO 10 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
6. HIDRALAZINA COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL
7. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
8. CARVEDILOL COMPRIMIDO 6,25 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. por 30 dias via ORAL

Control en: 15 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO